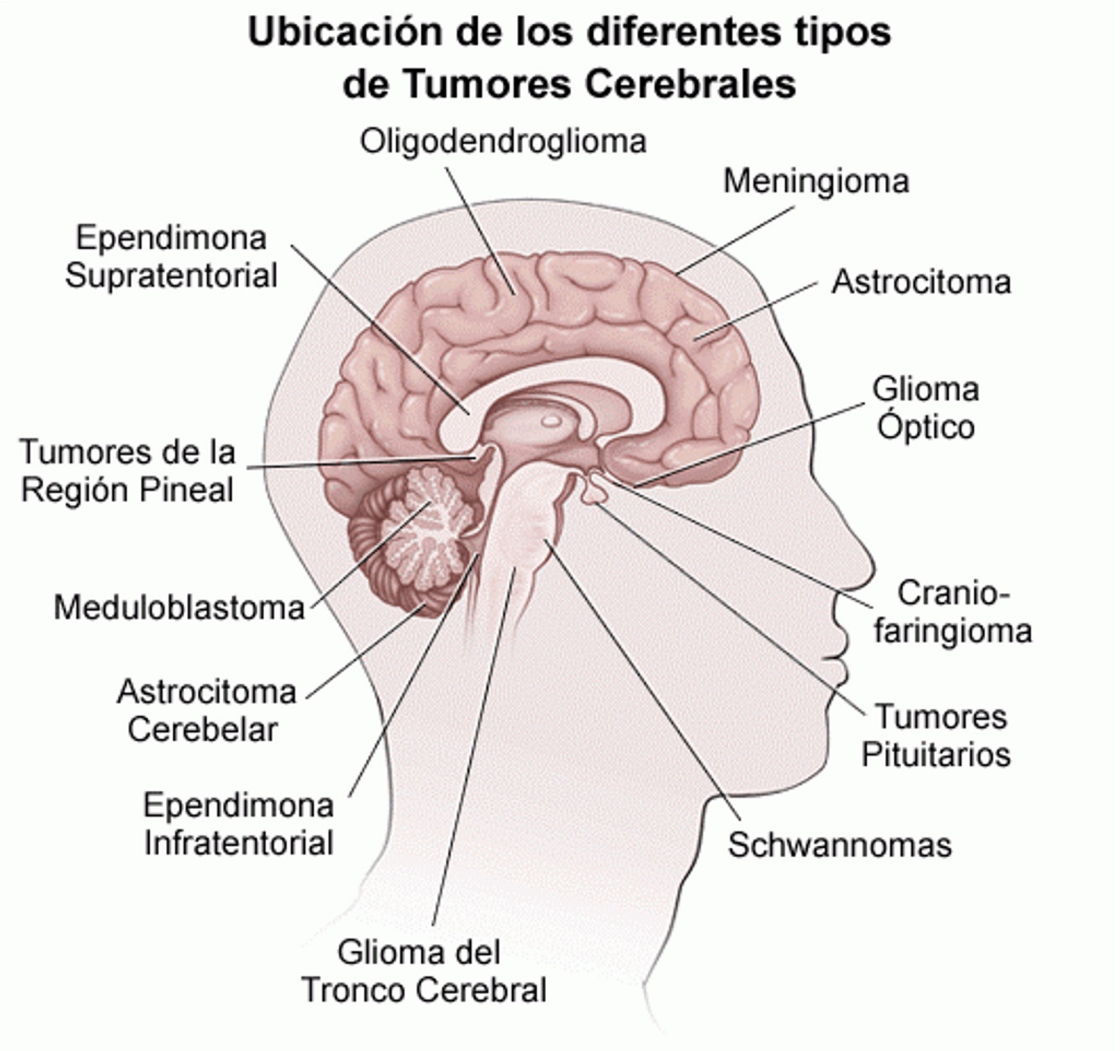
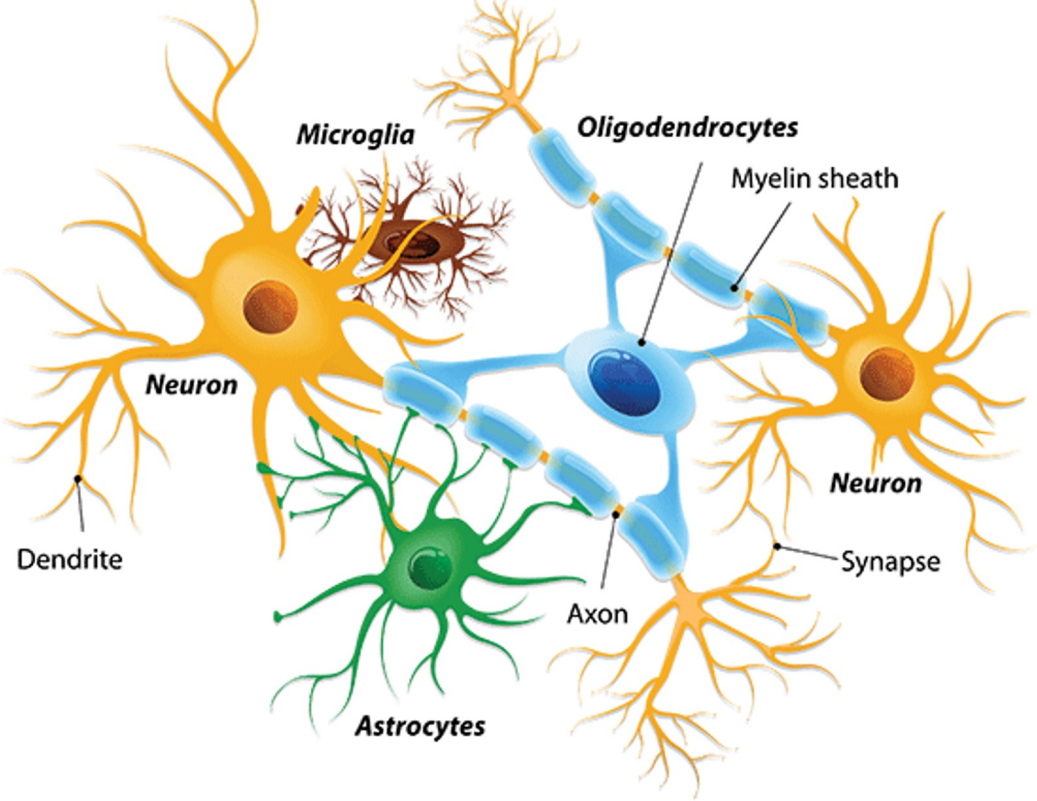
NEUROPATOLOGIA
DEMENCIAS Y OTRAS PATOLOGIAS

2022



TUMORES (NEOPLASIAS)



- Procesos expansivos que pueden formarse y crecer en cualquier region del cerebro.
- Tipo depende del la celula de origen
- 1º origen en el cerebro y 2º metastasis otra parte del cuerpo

TUMOR: GRADOS MALIGNIDAD

Organización Mundial de la Salud (OMS) los grados del tumor cerebral

Grado	Características	Tipos de tumores	
Bajo Grado	OMS Grado I	▪ Por lo menos maligno (benigno) ▪ Posiblemente curable mediante cirugía sola ▪ No infiltrante ▪ La supervivencia a largo plazo ▪ De crecimiento lento	Astrocitoma pilocítico craneofaringioma Gangliocitoma Ganglioglioma
	OMS grado II	▪ Crecimiento relativamente lento ▪ Algo infiltrante ▪ Puede reaparecer como de grado superior	"Difusa" astrocitoma Pineocitoma oligodendroglioma Pure
High Grade	OMS grado III	▪ Maligno ▪ Infiltrativa ▪ Tienden a repetirse como de grado superior	Astrocitoma anaplásico ependimoma anaplásico oligodendroglioma anaplásico
	OMS grado IV	▪ La mayor parte maligna ▪ El crecimiento rápido, agresivo ▪ Ampliamente infiltrante ▪ Recurrencia rápida ▪ Necrosis propensos	Multiforme glioblastoma (GBM) pineoblastoma meduloblastoma Ependimoblastoma

El grado del tumor se asocia con la severidad de los deficits neuropsicologicos. A mayor grado, mayor tamaño y agresividad interrumpiendo conecciones neurales

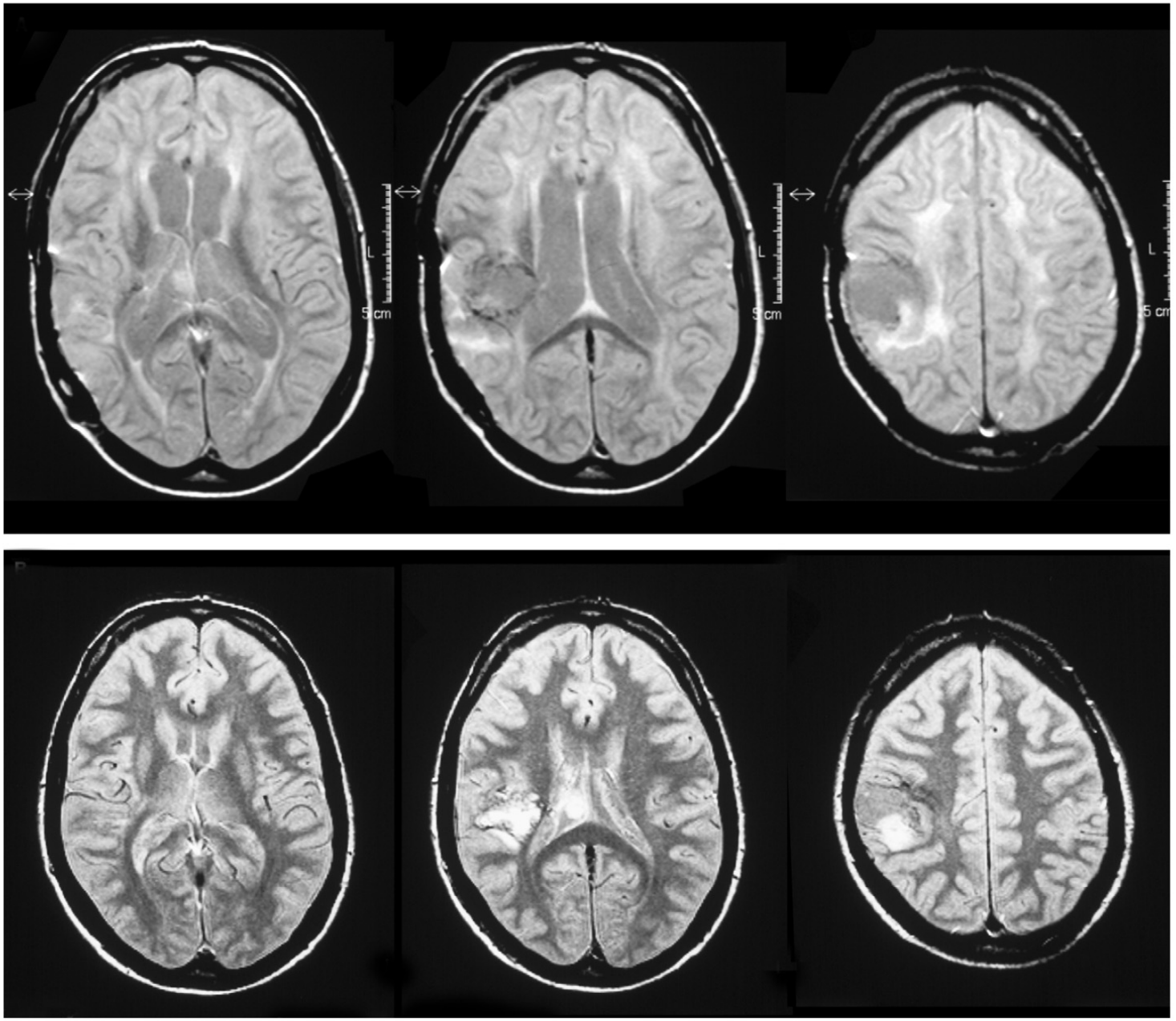
CAUSAS DE DEFICITS COGNITIVOS

- Deficits dependen de localizacion, tamaño y malignidad.
- **TUMOR**: daño al alrterar flujo nutriente, arquitectura de tejido y dañando areas cercanas.
- **CIRUJIA**: daño de tejido normal adyacente al tumor (deficit cognitivo focal). Evolución + tiempo.
- **RADIOTERAPIA**: neurotoxicidad post-radiacion (encefalopatia de radiacion desmielinación y daño vascular en encefalopatia tardia)

Brain tumours and cognitive deficits Review

Cognitive deficits in adult patients with brain tumours





T2-weighted MRI of a 43-year old man with a multifocal oligodendroglioma. Top: before radiotherapy, right parietal and intraventricular tumour. Bottom: 30 months after whole-brain radiotherapy (20 x 2 Gy); diffuse white-matter disease and communicating hydrocephalus. Reproduced with permission from Elsevier.[64]

PROCESOS INFECCIOSOS



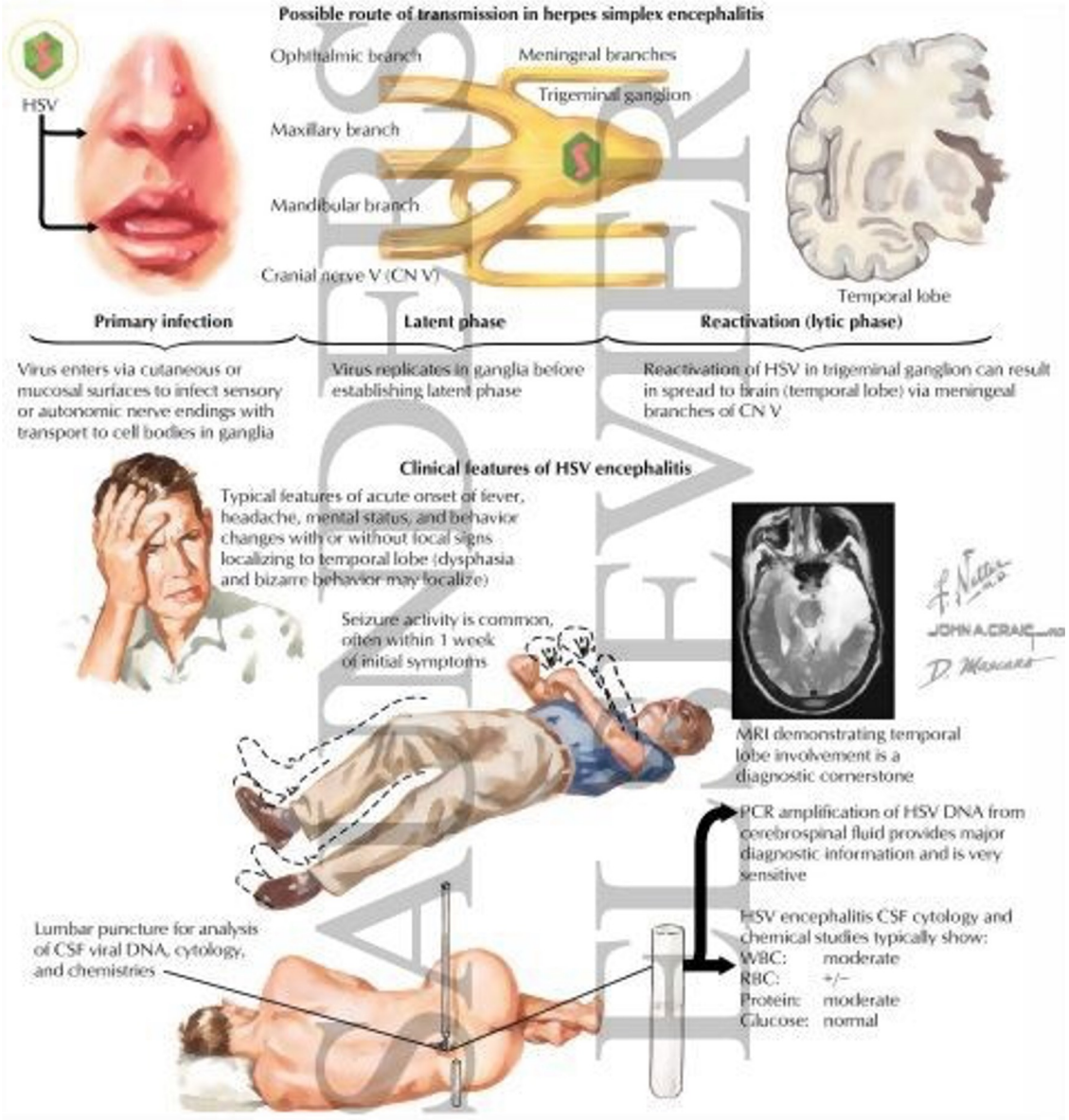
- Agentes patógenos (virus, bacteria, parásitos)
- Alteraciones propiedades electricas de las membranas neuronales, reducción flujo sanguineo, lesiones inflamatorias y abscesos.



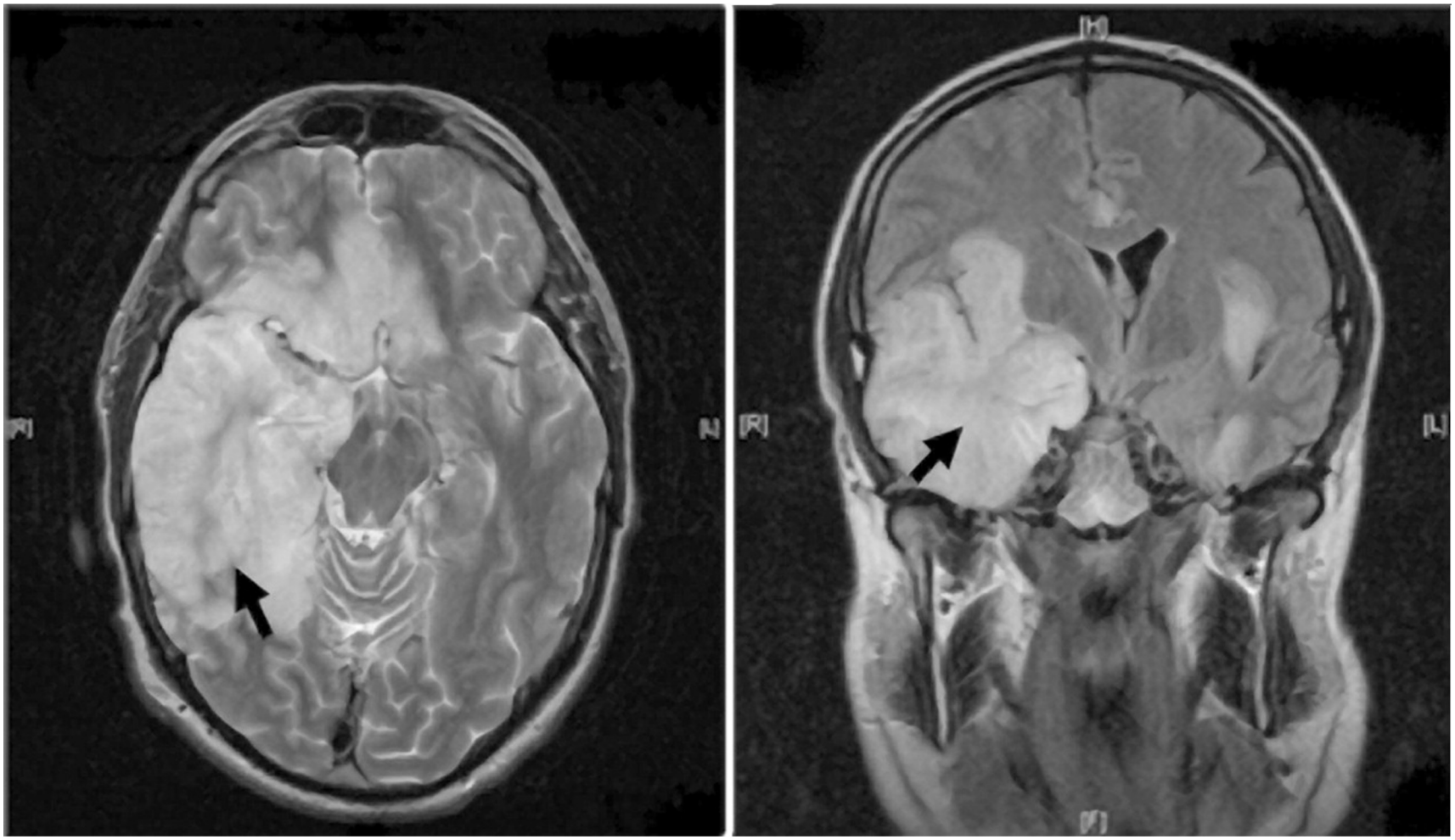
ENCEFALITIS HERPETICA

- Viral
- Cambios inflamatorios, destruccion de materia gris e inflamación meninges
- Aguda (deterioro rápido 2 dias: Virus Herpes Simplex), subaguda crónica (meses o semanas: VIH) e para-infecciosa
- Afecta lobulo temporal, hipocampo y amigdala
- Afasia, anomia, disfunción ejecutiva, Amnesia retrograde (semántica o episodica) y anterograde, deficits percepcion visual.





© ELSEVIER, INC. – NETTERIMAGES.COM

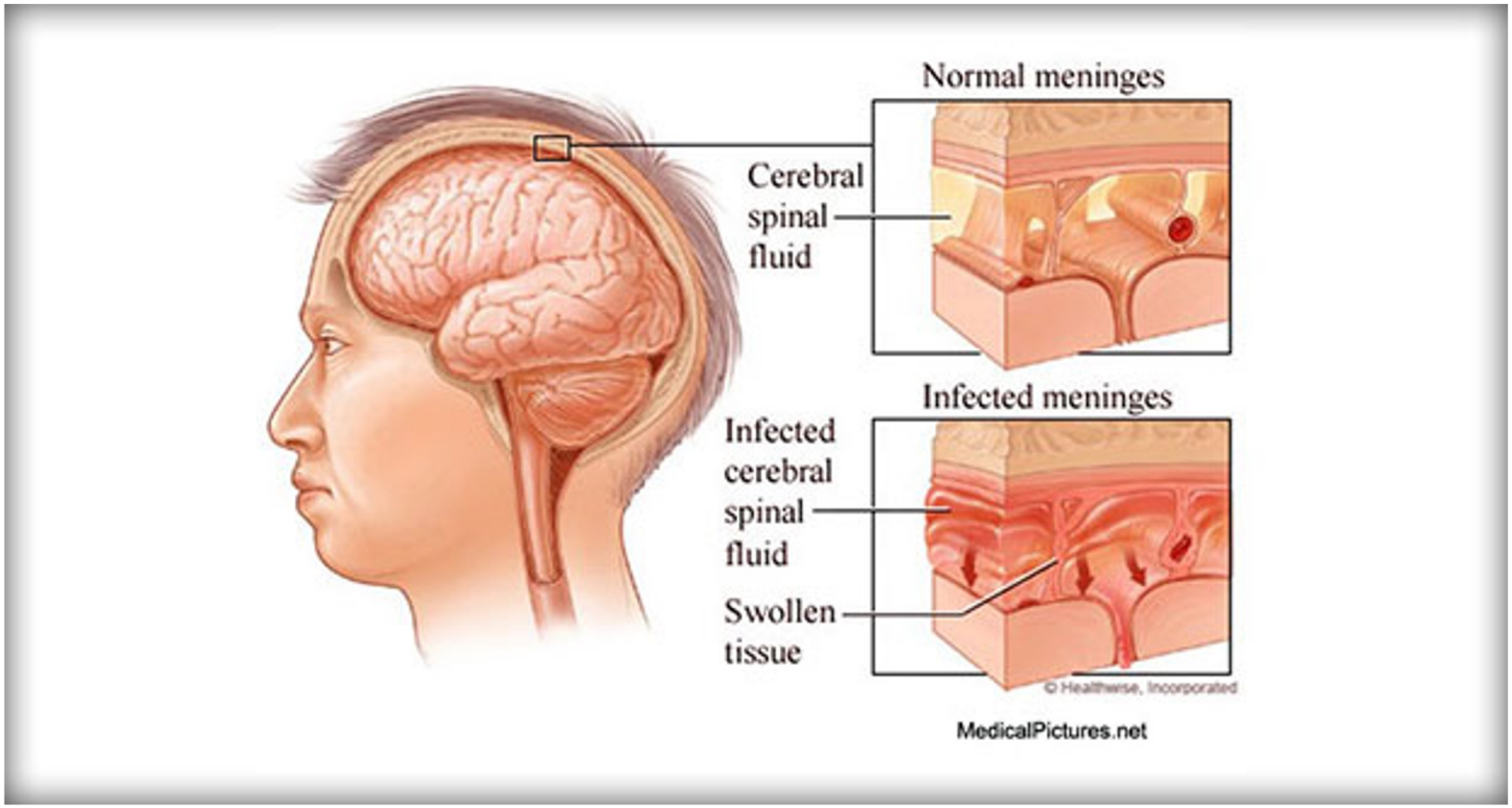


Axial and coronal T2 weighted magnetic resonance images showing areas of hyperintensity (arrowed) corresponding to oedematous changes in the temporal lobes and inferior frontal lobes with mass-like effect due to herpes simplex virus encephalitis. Reproduced with permission of Southampton General Hospital's picture library

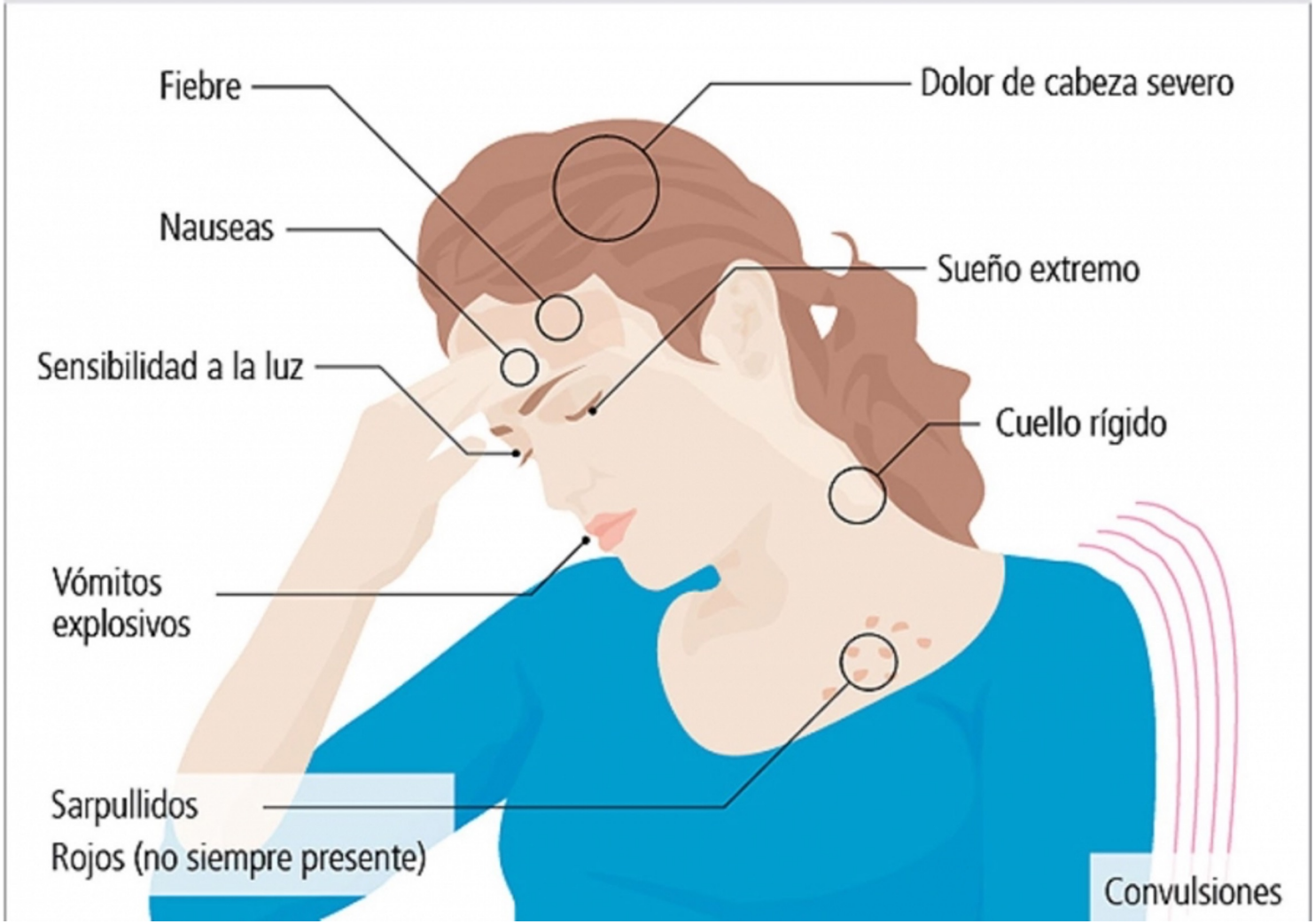
MENINGITIS

- Inflamación meninges de origen virico o bacteriano (mas graves).
- Inflamacion de las meninges interfiere con circulacion sanguinea y de LCR hidrocefalia
- Dificultades motoras, perceptuo-motoras, cognitivas y neurologicas
- Perfil neuropsicologico en bacteriana: memoria a corto plazo y de trabajo, función ejecutiva y aprendizaje verbal.



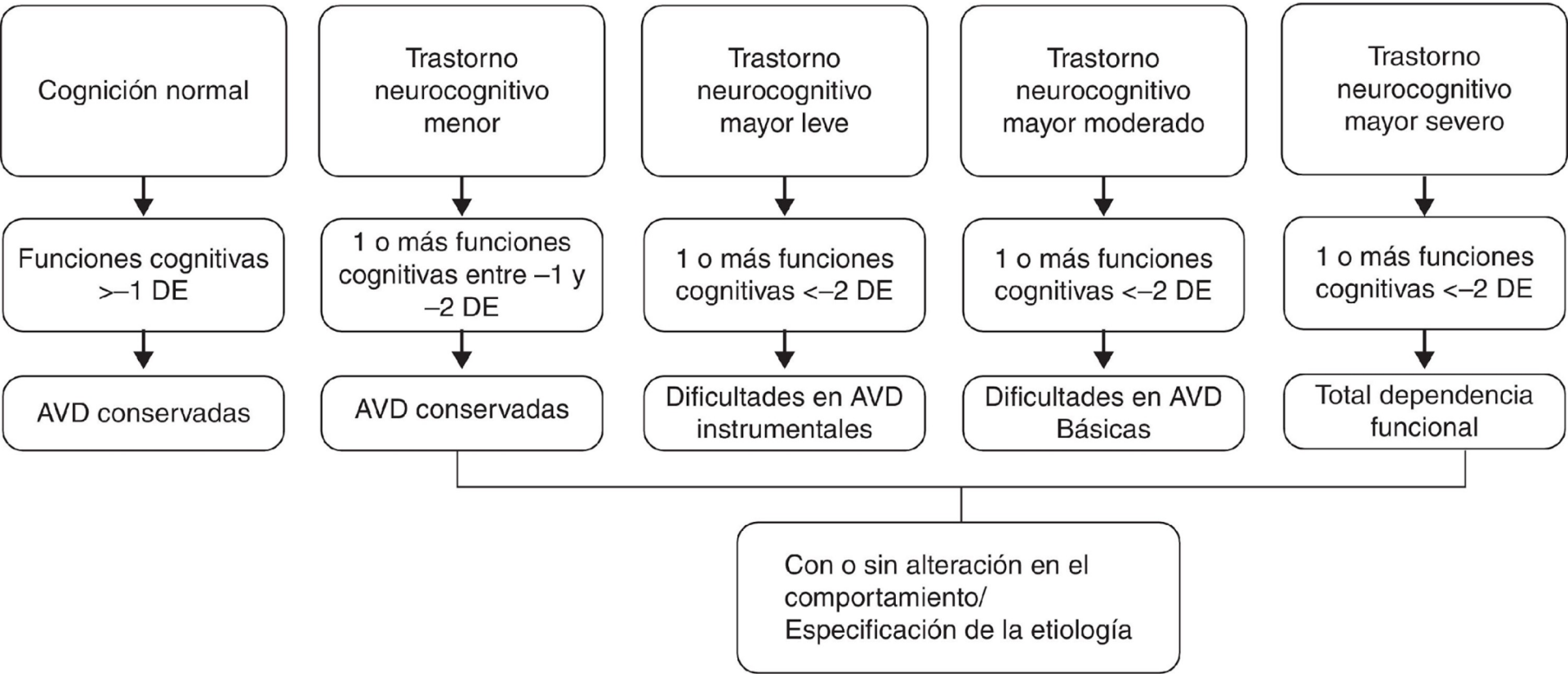

Normal meninges
Cerebral spinal fluid
Infected meninges
Infected cerebral spinal fluid
Swollen tissue
© Healthwise, Incorporated
MedicalPictures.net

Síntomas principales de la Meningitis



DETERIORO COGNITIVO LEVE, TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS MENOR Y MAYOR





Revisión

Del deterioro cognitivo leve al trastorno neurocognitivo menor: avances en torno al constructo

Fátima González Palau[a,*], *Federico Buonanotte*[b] y *Magdalena M. Cáceres*[c]

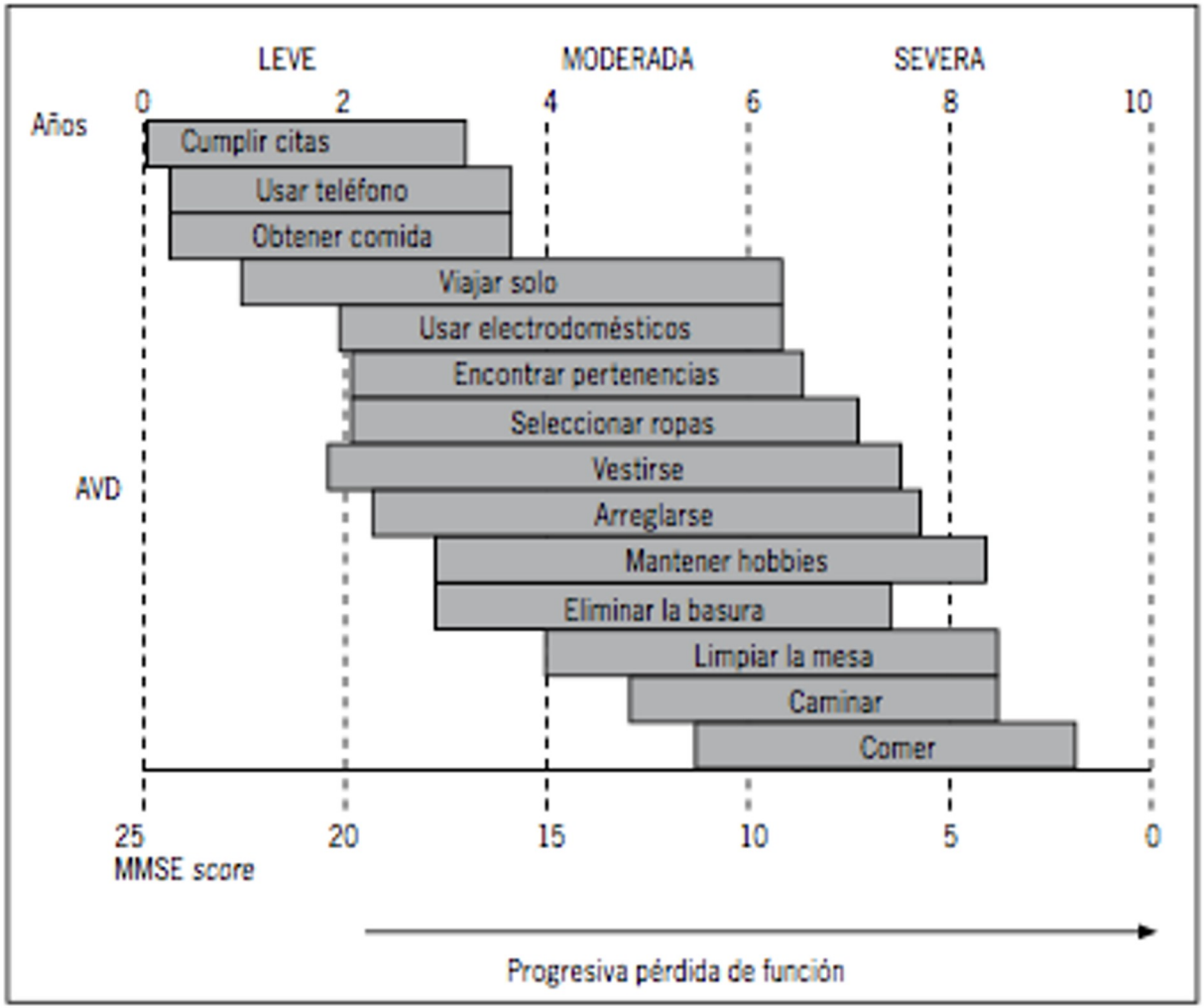


Figura 1. Correlación entre deterioro cognitivo y pérdida de funcionalidad.

Funcionalidad y demencia

Patricio Fuentes G.

TRASTORNO NEUROCOGNITIVO MENOR

Tabla I. Criterios diagnósticos propuestos en el DSM-5 para trastorno neurocognitivo menor.

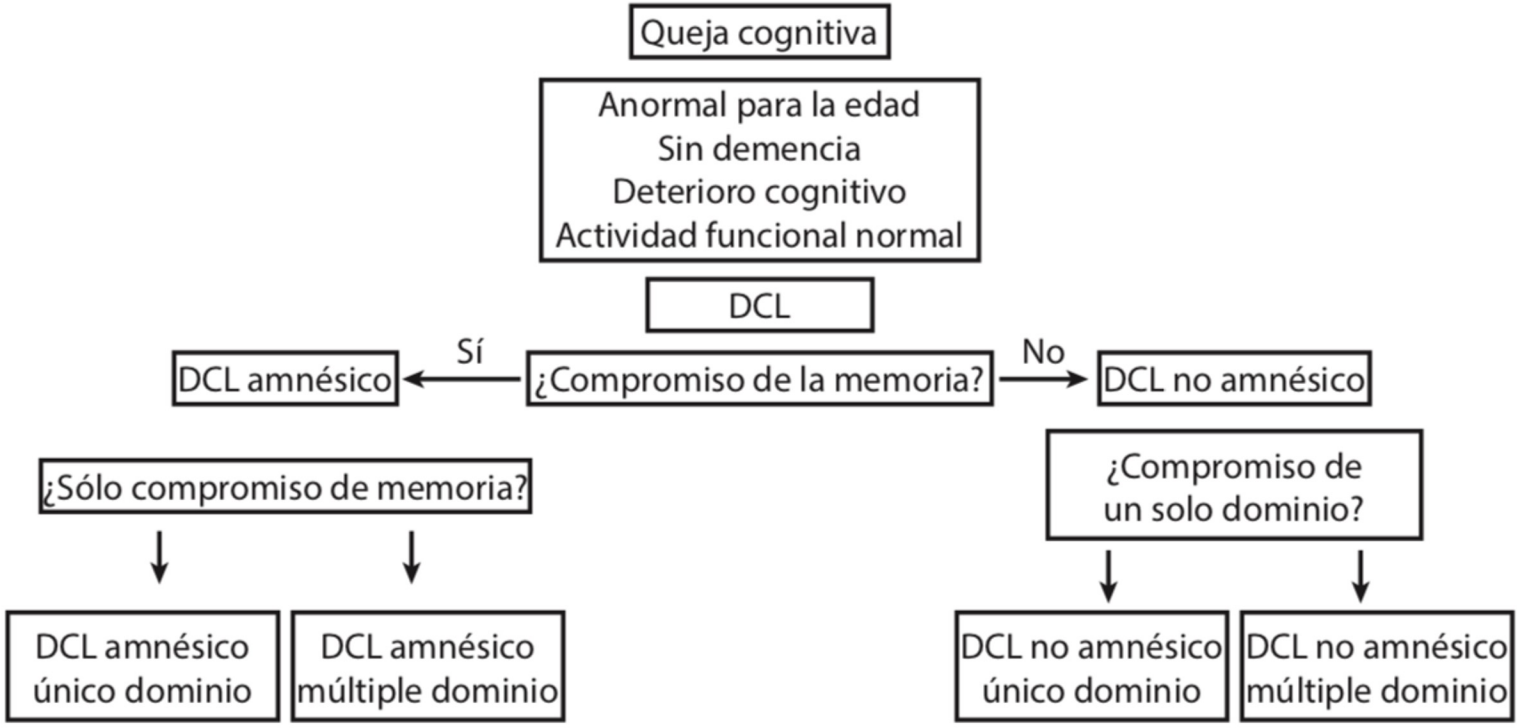
A. Evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de mayor desempeño en uno o más de uno de los dominios cognitivos referidos:
   1. Preocupación del individuo, de un tercero informado o del facultativo con respecto a un declive modesto en las funciones cognitivas
   2. Declive en el desempeño neuropsicológico, implicando un desempeño en los tests del rango de una a dos desviaciones estándares por debajo de lo esperado en la evaluación neuropsicológica reglada o ante una evaluación clínica equivalente

B. Los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia (p. ej., actividades instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como manejo de medicación o de dinero), pudiendo ser preciso esforzarse más, utilizar estrategias compensatorias o hacer una acomodación para mantener la independencia

C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un *delirium*

D. Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales (p. ej., trastorno depresivo mayor, esquizofrenia)

Figura 4. Algoritmo diagnóstico de deterioro cognitivo leve (DCL).



Fuente: Petersen RC, Negash S. Mild cognitive impairment an overview. CNS Spectr.2008;13(1):45-53.
Reproducido con autorización.

TRASTORNO NEUROCOGNITIVO MAYOR

Tabla 1. Criterios diagnósticos propuestos en el DSM-5 para trastorno neurocognitivo mayor*.

Criterios diagnósticos
a. Evidencia de una sustancial declinación cognitiva de un nivel previo de mayor desempeño en uno o más de los dominios cognitivos (aprendizaje y memoria, atención compleja, función ejecutiva, lenguaje, habilidad perceptual motora o cognición social).
b. Los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la independencia del paciente (por ejemplo, requieren asistencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como manejo de la medicación o dinero).
c. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio.
d. Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales (ejemplo: trastorno depresivo mayor, esquizofrenia).

*American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th. Edition (DSM-5). Washington DC: American Psychiatric Publishing; 2013

DEMENCIAS PRIMARIAS	
Demencias corticales	**Demencias subcorticales**
- **Enfermedad de Alzheimer** - **Demencia de cuerpos de Lewy** - **Demencia frontotemporales** - **Formas de inicio focal.** - **Formas infrecuentes (Esclerosis del hipocampo, calcificaciones de ganglios basales, encefalopatía con cuerpos de inclusión de neuroserpina).**	- Atrofia de múltiples sistemas - Degeneración corticobasal - Parálisis supranuclear progresiva - Enfermedad de Huntington - Demencia meso límbica-cortical - Gliosis subcortical progresiva - Heredoataxias progresivas. - Errores innatos del metabolismo (leucodistrofias, enf. De depósito)
DEMENCIA SECUNDARIA	
Demencia Vascular	
- **Isquémica:** **- Demencia multiinfarto / Demencia por infarto estratégico.** **- Por enfermedad de pequeño vaso.** - **Isquémico-hipóxica** - **Hemorrágicas**	
Demencia por medicamentos	
Demencia por tóxicos	
Demencia por traumatismos craneales	
Alteraciones vasculares y del colágeno	
Demencia de origen infeccioso: bacterianas, virales, hongos o priones.	
Mecanismos Expansivos intracraneales: Hidrocefalia normotensiva.	
Demencia asociado a carcinomas	
Demencia de origen endocrino-metabólico	
Demencia de origen carencial	

Diagnóstico diferencial TNC-M

- **Cuadros no adquiridos**: procesos congénitos grupo del retraso mental y la oligofrenia.

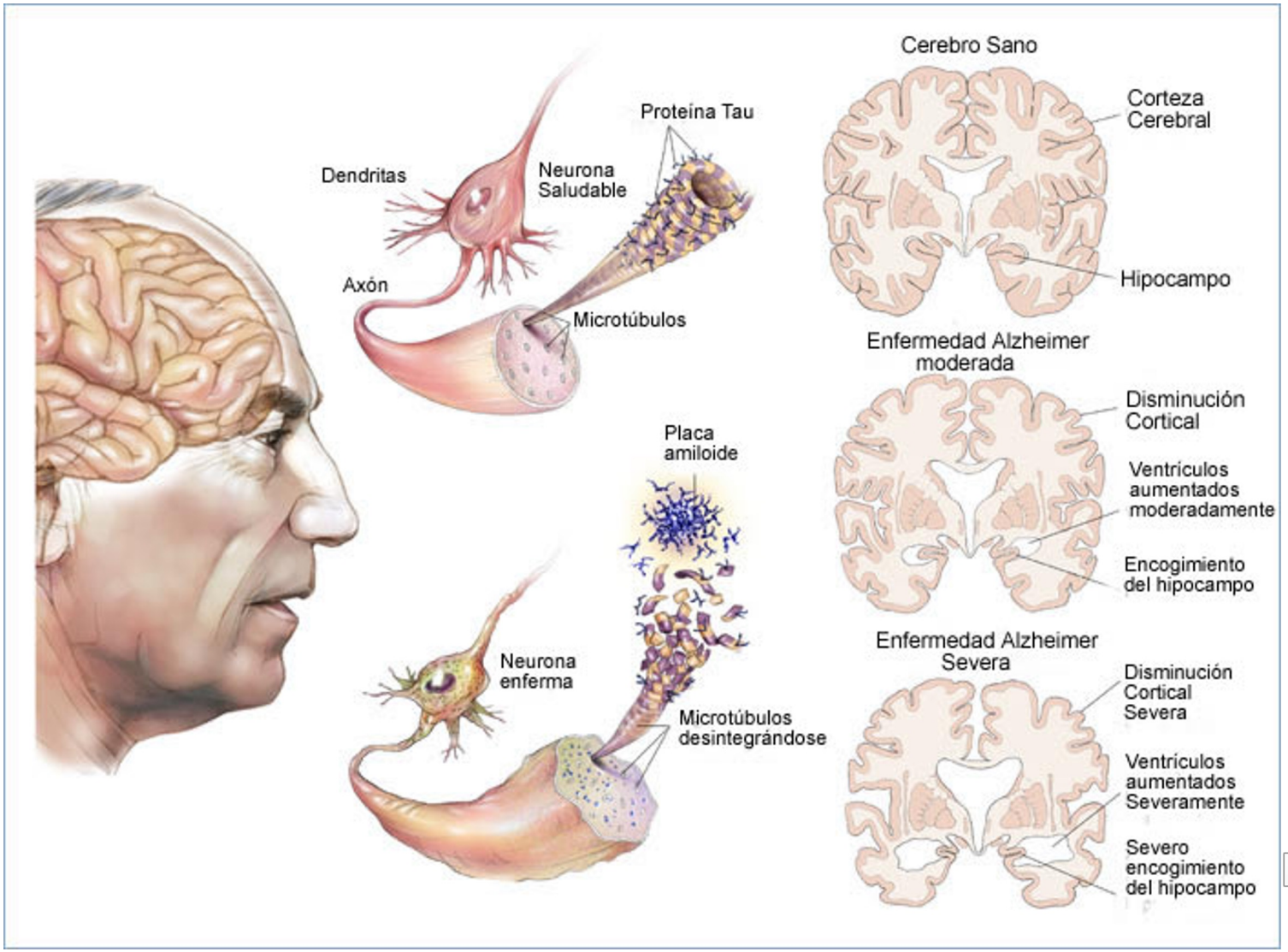
- **Cuadros no orgánicos**: "pseudodemencias" y que aparecen en relación con un trastorno psiquiátrico o simulación;

- **Cuadros con afectación del nivel de conciencia**: se incluye aquí el síndrome confusional agudo (Delirium).

- **Cuadros sin afectación cognitiva múltiple**: alteraciones del lenguaje, praxias, etc., en general secundarios a trastornos cerebrales focales.



TNC-M ALZHEIMER



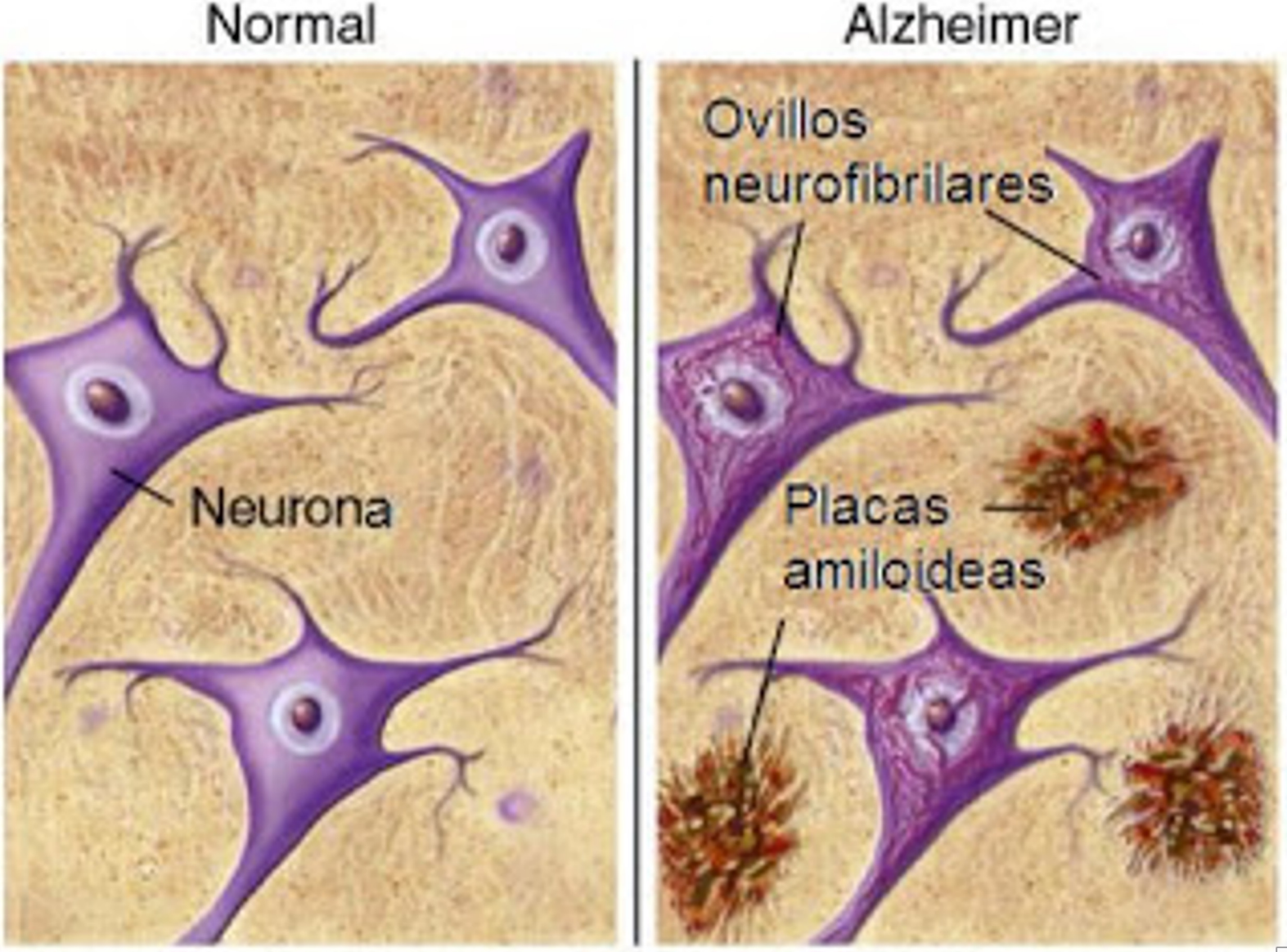
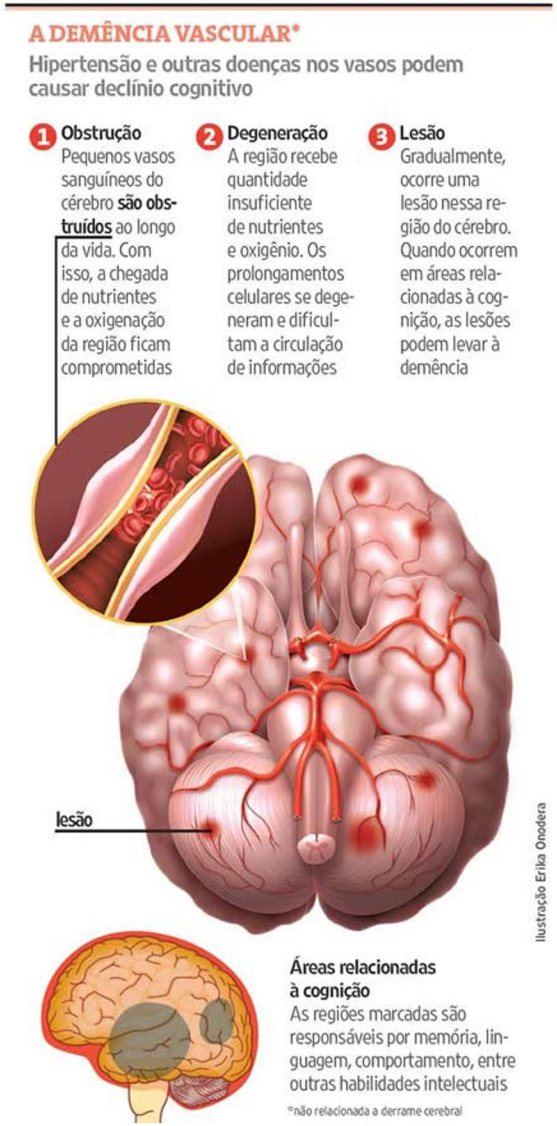

Normal
Alzheimer
Neurona
Ovillos
neurofibrilares
Placas
amiloideas

TABLA 1. ALTERACIONES COGNITIVAS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA DEMENCIA ALZHEIMER

	MEMORIA	FUNCIONES EJECUTIVAS	FUNCIONES INSTRUMENTALES
Etapa Leve	-Alteración de la Memoria Episódica -Alteración de la Memoria de Trabajo	Alteración de la Atención	-Anomia -Apraxia Reflexiva -Apraxia Visoconstructiva
Etapa Moderada	-Alteración de la Memoria Episódica -Alteración de la Metamemoria -Alteración de la Memoria Semántica -Alteración de la Memoria Retrógrada	Alteración de la Flexibilidad Mental	-Apraxia Ideomotora -Apraxia Ideatoria -Afasia -Dificultades de Compresión
Etapa Grave	-Alteración de la Memoria Episódica	Síndrome Disejecutivo	-Apraxia del Vestir -Ecolalia -Disartria -Mutismo -Agnosia Aperceptiva

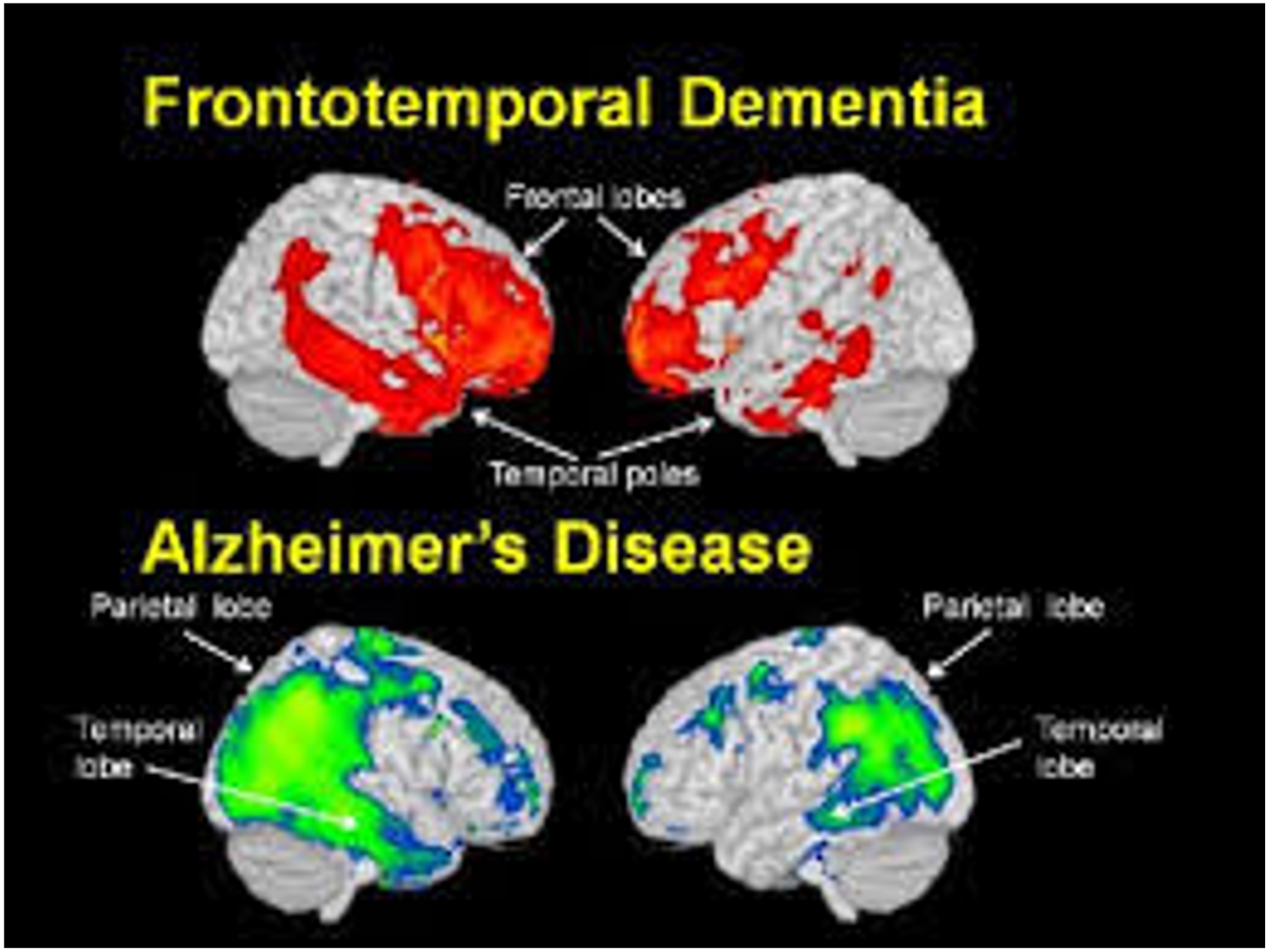


TNC-M VASCULAR



- Mayor compromiso atenicion sostenida y lenguaje (v/s memoria)
- Oscilacion deficits durante el dia
- Depresion

TNCM-FRONTOTEMPORAL



TIPOS

- CONDUCTUAL
  - ATROFIA FRONTOTEMPORAL (CAMBIOS CONDUCTUALES Y DE PERSONALIDAD: APATIA, DESHINIBICION, EUFORIA, DEPRESION)
- AFASIA PROGRESIVA PRIMARIA NO FLUENTE
  - LESIONES FRONTOTEMPORALES IZQUIERDAS CON TRASTORNOS DEL LENGUAJE (DENOMINACION DE PALABRAS Y ORDEN GRAMATICAL)
- DEMENCIA SEMANTICA
  - ATROFIA LOBULO TEMPORAL (MEMORIA SEMANTICA, ENCONTRAR PALABRAS Y LENGUAJE COMPRENSIVO)



TNCM-PRKINSON

Diseases of the Brain | Progressive conditions affect the body and mind in different ways

Alzheimer's symptoms

Cognitive: Memory loss and deterioration in thinking and planning functions.

Physical: In mid-stage, disease could include slowness, rigidity and tremors.

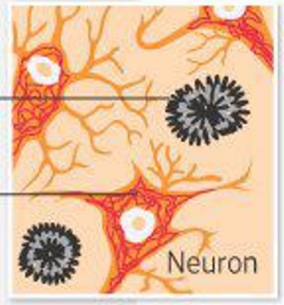
INSIDE THE BRAIN

The cortex, particularly the **hippocampus**, key to memory, shrinks.

Ventricles (fluid-filled spaces within the brain) enlarge.

Plaques (amyloid deposits) cluster between neurons.

Tangles (twisted proteins) are found within neurons.



Parkinson's symptoms

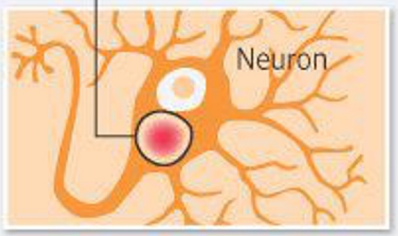
Cognitive: Loss of executive functions, including planning, decision-making and controlling emotions.

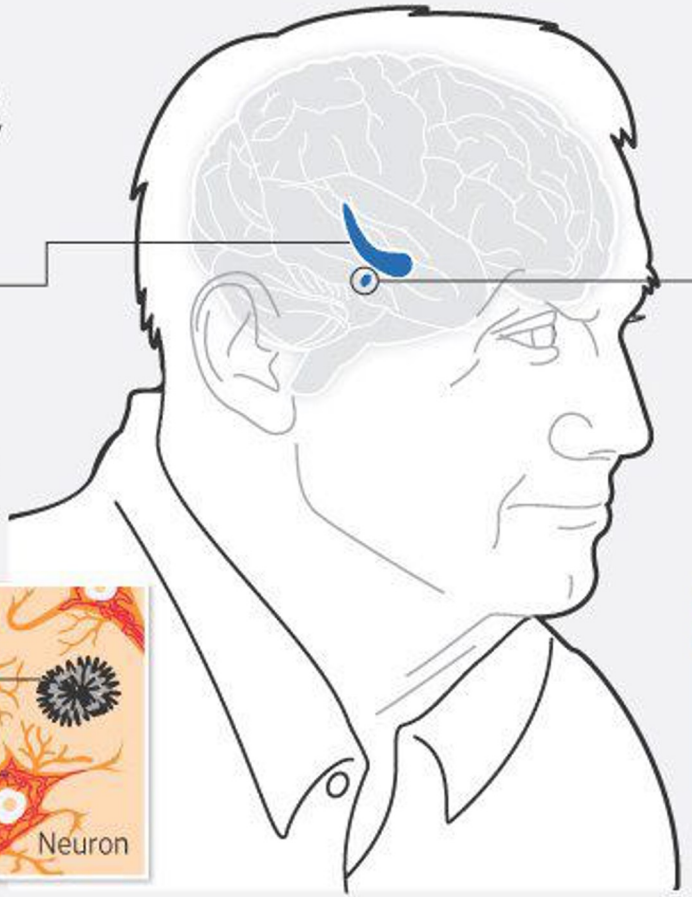
Physical: Tremors, stiffness and slowed movements.

INSIDE THE BRAIN

Cells shrink in the **substantia nigra**, where dopamine is produced.

Lewy bodies (clusters of alpha-synuclein protein) accumulate inside neurons.





Sources: Alzheimer's Association, Parkinson's Disease Foundation and helpguide.org



Tremor



Tremor of one hand is an early manifestation of parkinsonism



Tremor often improves or disappears with purposeful function

Bradykinesia



Difficulty in performing simple manual functions may be initial symptom

Rigidity and Gait Disorders



Stage 1: unilateral involvement; blank facies; affected arm in semiflexed position with tremor; patient leans to unaffected side



Stage 2: bilateral involvement with early postural changes; slow shuffling gait with decreased excursion of legs



Stage 3: pronounced gait disturbances and moderate generalized disability; postural instability with tendency to fall



Late Stage Disabilities

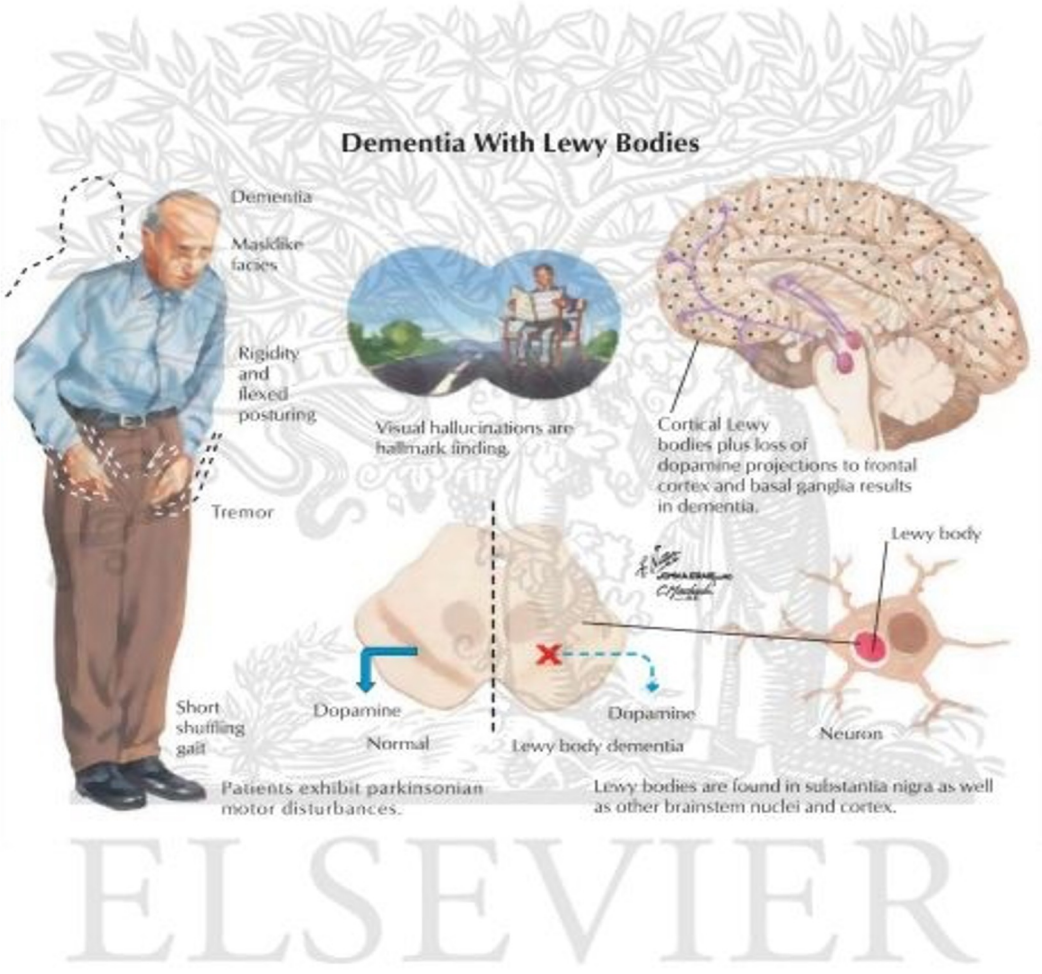


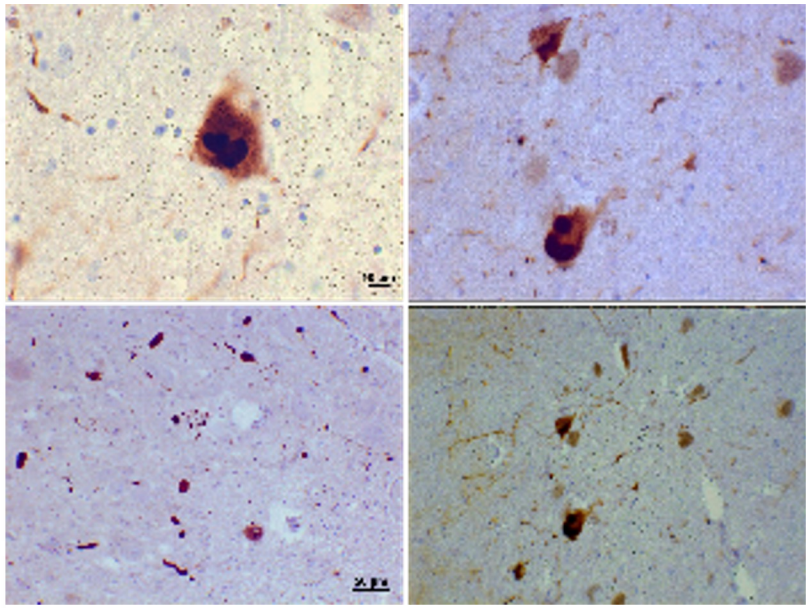
Stage 4: significant disability; limited ambulation with assistance



Stage 5: complete invalidism; patient confined to bed or chair; cannot stand or walk even with assistance

TNCM-CUERPOS DE LEWY





TRASTORNOS DEL SUENO
CAIDAS
ALTERACIONES VISOPERCEPTIVAS

Pareidolia: reconocer patrones significativos en Estímulos vagos y aleatorios

Personas con sintomatología alucinatoria y Dx de DCL presentaban mayor número de Pareidolias.

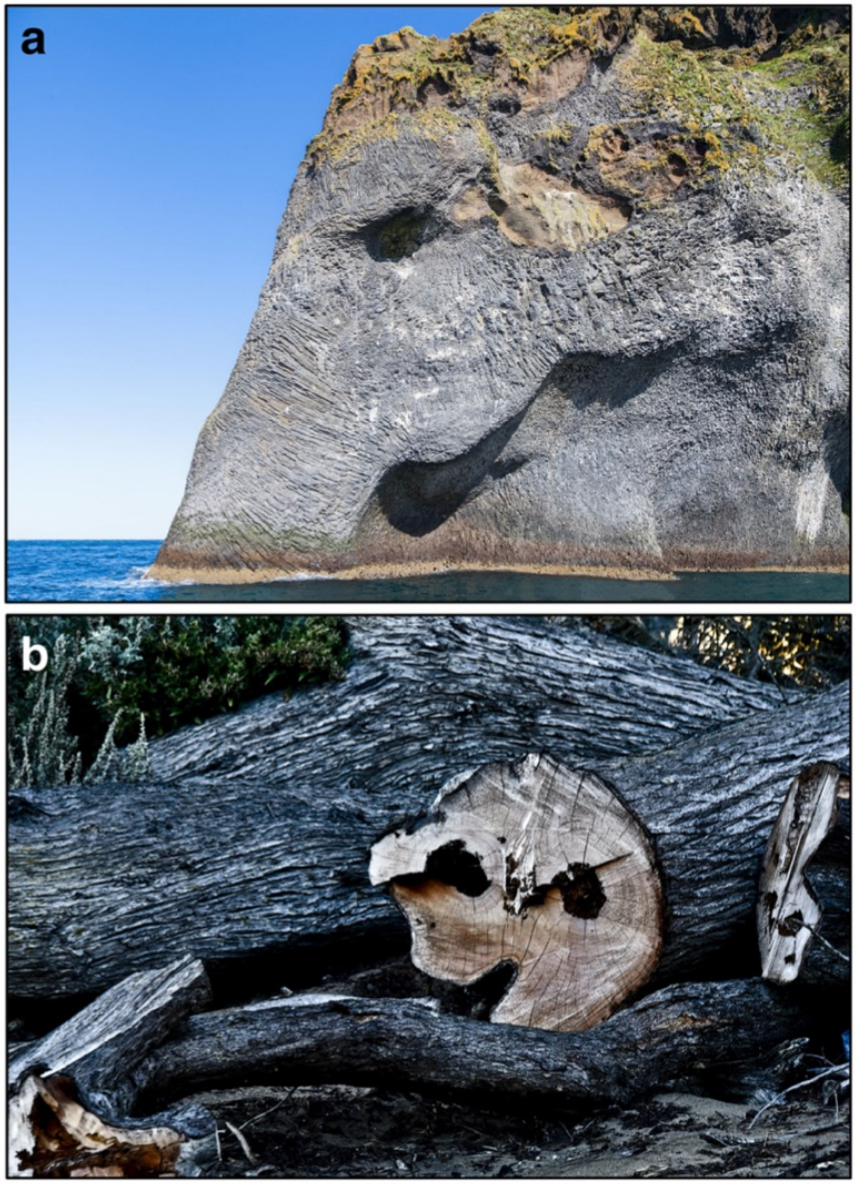


Fig. 1 Examples of naturally occurring pareidolia: (**a**) elephant rock (Delso, 2014); (**b**) face in tree trunk (Denyer, n.d.)

Compensatory shifts in visual perception are associated with hallucinations in Lewy body disorders

Alan Robert Bowman[1*], Vicki Bruce[2], Christopher J. Colbourn[1] and Daniel Collerton[3]

	EA	DV	DLFT	DL	Hidrocefalia
Clínica inicial	Pérdida de memoria episódica	Aparición súbita con deterioro escalonado	Cambios en comportamiento, personalidad y lenguaje	Alucinaciones, parkinsonismo, delirio	Defectos en la marcha
Deterioro Cognitivo	Predomina pérdida de memoria con pérdida de otros dominios cognitivos	Función ejecutiva, lentitud generalizada	Función ejecutiva, lenguaje, comportamiento	Fluctuaciones con pérdida de nivel de consciencia	Defecto leve de la memoria, confusión
Exploración Neurológica	Inicialmente normal	Debilidad, espasticidad, déficits neurológicos focales	Distonía, rigidez axial	Parkinsonismo	Apraxia de la marcha
Exploración Psiquiátrica	Inicialmente normal	Apatía, ilusiones, ansiedad	Apatía, desinhibición	Delirio, alucinaciones, depresión, ilusiones	Confusión
Neuroimagen	Atrofia en cortex entorrinal e hipocampal	Infartos corticales/sub corticales y alteraciones en la sustancia blanca	Atrofia frontal y temporal	Atrofia cortical difusa, mayor en mesencéfalo	Dilatación ventricular

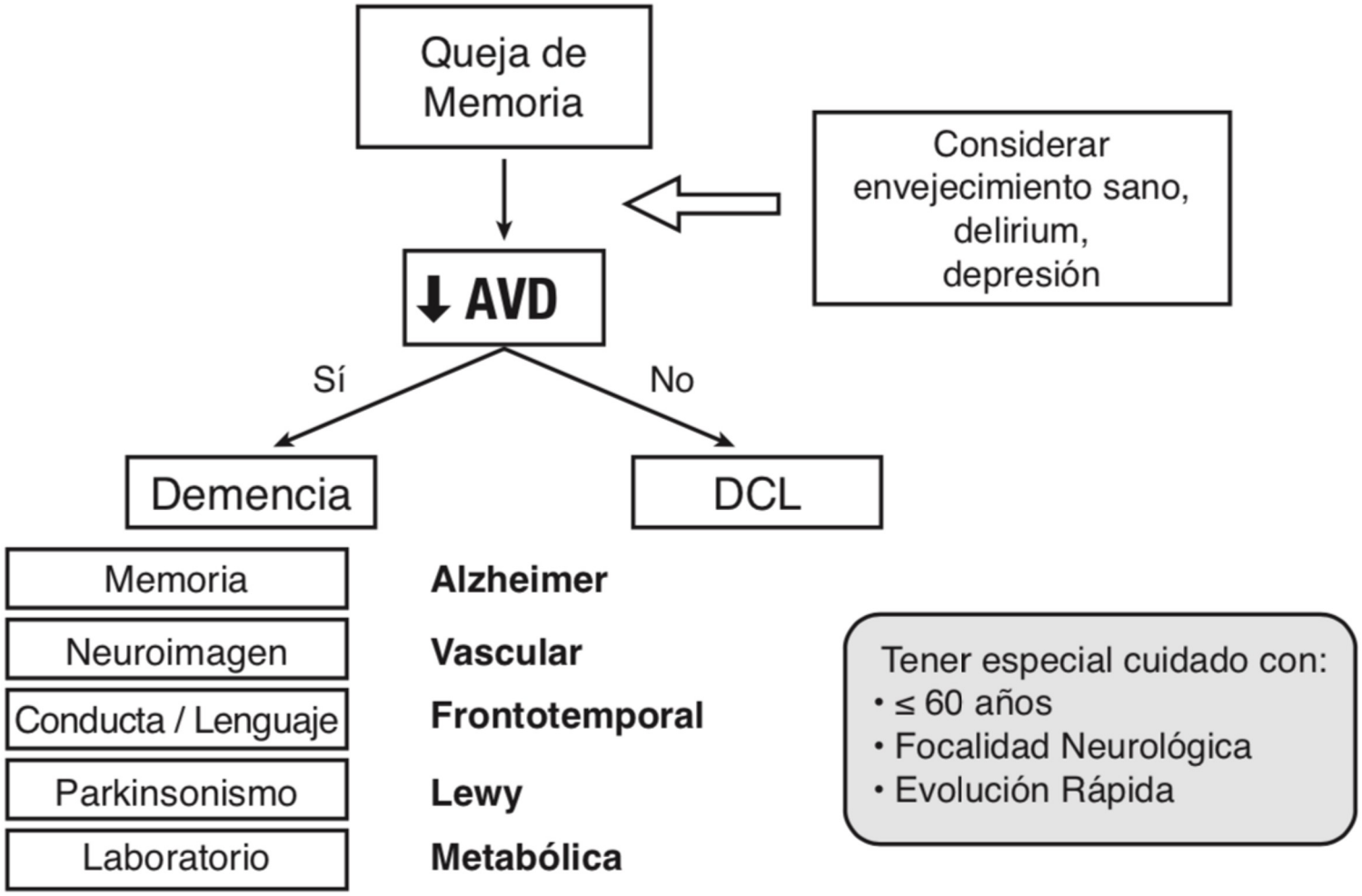
Tabla 2 – Diagnóstico diferencial de las demencias más frecuentes – EA: Enfermedad de Alzheimer. DV: Demencia vascular. DLFT: Degeneración lobar frontotemporal. DL: Demencia de cuerpos de Lewy

TABLA 4. PRINCIPALES ALTERACIONES COGNITIVAS Y NEUROPSIQUIÁTRICAS DE LAS DEMENCIAS

	DEMENCIA ALZHEIMER	DEMENCIA VASCULAR	DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY	DEMENCIA PARKINSON	DEMENCIA FRONTOTEMPORAL
Forma del Deterioro Cognitivo	Progresivo	Fluctuante y en ocasiones progresivo	Fluctuante y rápido	Progresivo y lento	Fluctuante
Alteraciones Cognitivas	Alteraciones de Memoria (episódica, semántica, retrógrada)	Alteración Atencional	Alteración de Capacidades Visoconstructivas+++	Alteraciones Visoespaciales	Trastornos del Lenguaje
	Apraxia	Alteración de la Flexibilidad Mental	Alteraciones de Funciones Ejecutivas	Alteración de Capacidades Visoconstructivas++	Alteración de Funciones Ejecutivas
	Agnosia	Disminución de la velocidad de procesamiento de la información		Alteración de Funciones Ejecutivas++	Atención ++
	Alteración de Capacidades Visoconstructivas+	Alteración en la Planificación		Alteración Memoria de Trabajo	Alteración de Capacidades Visoconstructivas+
		Alteraciones de Memoria (Variables)		Alteraciones Atencionales++	
		Alteración de la Fluencia Verbal (variando en función de la lesión cerebral)		Trastornos del Lenguaje (Disartria, Trastornos en la comprensión y producción de frases complejas)	
		Alteración del lenguaje			
Alteraciones Neuropsiquiátricas	Apatía	Depresión	Alucinaciones+++	Depresión	Cambio de personalidad
	Ansiedad	Apatía	Psicosis	Apatía	Apatía
	Depresión	Irritabilidad		Alucinaciones	Desinhibición
	Delirios	Agresividad		Psicosis	Euforia
	Agitación	Ansiedad			Disforia
	Estados Confusionales				
	Alucinaciones (en etapas avanzadas)				



Figura 3. Algoritmo básico de diagnóstico diferencial de demencia.



AVD: Actividades de la vida diaria

DCL:Deterioro cognitivo leve

CASO FELIPE J SOSPECHA DEMENCIA

- 00` Felipe
- 30` esposa

Escala de Deterioro Global (GDS)

GDS 1. (Ausencia de alteración cognitiva)

Ausencia de quejas subjetivas. Ausencia de trastornos de la memoria evidentes en la entrevista clínica.

GDS 2. (Disminución cognitiva muy leve)

Quejas subjetivas de defectos de la memoria, sobre todo en las siguientes áreas:
- Olvido de dónde ha dejado objetos familiares.
- Olvido de nombres previamente bien conocidos.

No hay evidencia objetiva de defectos de la memoria en la entrevista clínica. No hay evidencia de defectos objetivos en el trabajo o en situaciones sociales.
Preocupación adecuada respecto a la sintomatología.

GDS 3. (Defecto cognitivo leve). Primeros defectos claros

Manifestaciones en más de una de las siguientes áreas:
- El paciente puede haberse perdido yendo a un lugar no familiar.
- Los compañeros de trabajo son conscientes de su poco rendimiento laboral.
- El defecto para evocar palabras y nombres se hace evidente a las personas cercanas.
- El paciente puede leer un pasaje de un libro y recordar relativamente poco material.
- El paciente puede mostrar una capacidad disminuida en el recuerdo del nombre de personas nuevas conocidas recientemente.
- El paciente puede haber perdido o colocado un objeto de valor en un lugar equivocado.
- En la exploración clínica, puede hacerse evidente un defecto de concentración.

Se observa evidencia objetiva de defectos de memoria únicamente en una entrevista intensiva.
Rendimientos disminuidos en actividades laborales y sociales exigentes. La negación o el desconocimiento de los defectos pasan a ser manifestados por el paciente. Los síntomas se acompañan de ansiedad discreta a moderada.

GDS 4. (Defecto cognitivo moderado). Defectos claramente definidos en una entrevista clínica cuidadosa

Déficits manifestados en las siguientes áreas:
- Conocimiento disminuido de los acontecimientos actuales y recientes.
- El paciente puede presentar cierto déficit en el recuerdo de su historia personal. - Defecto de concentración puesto de manifiesto en la sustracción seriada.
- Capacidad disminuida para viajar, control de su economía, etc.

Frecuentemente no hay déficit en las siguientes áreas:
- Orientación en tiempo y persona.
- Reconocimiento de personas y caras familiares.
- Capacidad para viajar a lugares familiares.
- Incapacidad de realizar tareas complejas.

La negación es un mecanismo de defensa dominante. Se observa diminución del afecto y abandono en las situaciones más exigentes.

GDS 5. (Defecto cognitivo moderado-grave). El paciente no puede sobrevivir mucho tiempo sin ninguna asistencia.

Durante la entrevista, es incapaz de recordar aspectos importantes y relevantes de su vida actual.
- Dirección o número de teléfono de muchos años.
- Nombres de familiares próximos (como los nietos).
- El nombre de la escuela o institución donde estudió.

A menudo presenta cierta desorientación en tiempo (fecha, día de la semana, estación del año, etc.) o en lugar.
Una persona con educación formal puede tener dificultades para contar hacia atrás desde 40 de 4 en 4 o desde 20 de 2 en 2.
Las personas en este estadio mantienen el conocimiento de muchos de los hechos de más interés que les afectan a ellos mismos y a otros.
Invariablemente conocen su nombre y, en general, saben el nombre de su cónyuge e hijos.
No requieren asistencia ni en el aseo ni al comer, pero pueden tener alguna dificultad en la elección de la vestimenta adecuada.

GDS 6. (Defecto cognitivo grave)

Ocasionalmente puede olvidar el nombre del cónyuge, de quien, por otra parte, generalmente depende totalmente para sobrevivir.
Desconoce, en gran parte, los acontecimientos y experiencias recientes de su vida.
Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, pero muy fragmentariamente.
Generalmente desconoce su entorno, el año, la estación, etc.
Puede ser incapaz de contar hasta diez hacia atrás y a veces hacia adelante.
Requiere asistencia en las actividades cotidiana.
Puede presentar incontinencia.
Puede requerir asistencia para viajar, pero, ocasionalmente, será incapaz de viajar a lugares familiares.
El ritmo diurno es frecuentemente alterado.
Casi siempre recuerda su nombre.
Con frecuencia sigue siendo capaz de distinguir entre las personas familiares y no familiares de su entorno.
Ocurren cambios emocionales y de personalidad que son bastante variables e incluyen:
- Conducta delirante, p. ej., acusar al cónyuge de ser un impostor, hablar con personas imaginarias o con su imagen reflejada en el espejo.
- Síntomas obsesivos, p. ej., puede repetir continuamente actividades de limpieza.
- Síntomas de ansiedad, agitación; incluso puede aparecer una conducta violenta previamente inexistente.
- Abulia cognitiva, p. ej., pérdida de deseos por falta del desarrollo suficiente de un pensamiento para determinar una acción propositiva.

GDS 7. (Defecto cognitivo muy grave)

A lo largo de esta fase, se pierden todas las capacidades verbales.
En las fases tempranas de este estadio se pueden producir palabras y frases, pero el lenguaje es muy circunscrito.
En las últimas fases de este periodo no hay lenguaje, solo gruñidos.
Incontinencia urinaria. Requiere asistencia en el aseo y la alimentación.
Las habilidades psicomotoras básicas (p. ej., deambular) se pierden a medida que avanza esta fase.
El cerebro parece incapaz de decirle al cuerpo lo que tiene que hacer. A menudo hay signos y síntomas neurológicos generalizados y corticales.

FIN



TABLA IX

Esquema de Wells para el diagnóstico de Pseudodemencia

PSEUDODEMENCIA	DEMENCIA
Historia y curso clínico	
Familia consciente de la disfunción	Familia poco consciente de la disfunción
Inicio que se puede precisar	Inicio poco preciso
Síntomas de corta duración antes de la búsqueda de ayuda médica	Síntomas de larga duración antes de la búsqueda de ayuda médica
Rápida progresión de los síntomas	Lenta progresión de los síntomas
Antecedentes de trastorno afectivo	No hay antecedentes de trastorno afectivo
Quejas del paciente y conducta clínica	
Se queja mucho de su pérdida cognitiva	No se queja de su pérdida cognitiva
Da quejas detalladas de su disfunción	Da detalles vagos de su disfunción cognitiva
Enfatiza el trastorno	Disimula el trastorno
Remarca los fracasos	Remarca los logros, incluso triviales
Hace poco esfuerzo en las tareas	Se esfuerza en las tareas
No intenta "mantenerse"	Usa notas, calendarios, etc., para "mantenerse" y "no quedarse atrás"
Comunica un fuerte sentido de distrés	Aparece sin preocuparse
Marcado cambio afectivo	Cambio afectivo poco marcado
Pérdida de hábitos sociales precoz y marcada	Mantenimiento de los hábitos sociales
Conducta incongruente con la gravedad de la disfunción cognitiva	Conducta compatible con la pérdida cognitiva
Poco frecuente el empeoramiento nocturno	Muy frecuente el empeoramiento nocturno

Signos clínicos relativos a la disfunción mnésica y cognitiva	
Atención y concentración bien preservadas a menudo	Usual déficit de atención y concentración
"No lo sé" como respuesta típica	Frecuentes respuestas de "casi fracaso"
En los test de orientación, los pacientes dan a menudo respuestas "no lo sé"	En los test de orientación, confunden lo inusual con lo usual
La pérdida mnésica para hechos recientes y remotos usualmente es de igual intensidad	La pérdida de memoria para hechos recientes es más acusada que para remotos
Frecuentes lagunas mnésicas para períodos específicos o sucesos	Inusual que haya lagunas mnésicas para períodos específicos
Marcada variabilidad en la ejecución de tareas de similar dificultad	Mala ejecución de forma continua en tareas de dificultad similar

TABLA VIII

Criterios de HAM para el diagnóstico diferencial entre delirium y demencia

DELIRIUM	DEMENCIA
■ Comienzo preciso, brusco, con fecha identificable.	■ Comienzo gradual que no se puede fechar con exactitud.
■ Enfermedad aguda, por lo general de días a semanas, raramente más de 1 mes.	■ Enfermedad crónica, que progresa de forma característica durante años.
■ Por lo general reversible, a menudo completamente.	■ Por lo general irreversible, a menudo crónicamente progresiva.
■ Desorientación precoz.	■ Desorientación en la fase tardía de la enfermedad, a menudo después de transcurridos meses o años.
■ Variabilidad de momento a momento, de hora a hora, durante todo el día.	■ Mucho más estable de un día para otro (a menos que aparezca delirium).
■ Alteraciones fisiológicas destacadas.	■ Cambios fisiológicos menos llamativos.
■ Nivel de consciencia turbio, alterado y cambiante.	■ La consciencia no se obnubila hasta la fase terminal.
■ Duración de la atención llamativamente corta.	■ La duración de la atención no está reducida de forma característica.
■ Alteración del ciclo sueño-vigilia, con variaciones de hora en hora.	■ Alteración del ciclo sueño-vigilia con inversión día-noche, sin variaciones horarias.
■ Marcados cambios psicomotores (hiperactivo o hipoactivo)	■ Alteraciones psicomotoras característicamente tardías (a menos que aparezca depresión).